

1. A) Göra gott

Hon har gjort det hon ska praktiskt. Men kränkt brukarens integritet eftersom hon inte talar om vad de ska göra, hur det ska gå till, utan sliter bort täcket och drar ned kalsongerna utan att han informerat brukaren om att de ska spola katetern. Dessutom har hon en elev med sig som hon inte presenterat eller frågat brukaren om det är okej att han är med och observerar. Sjuksköterskan säger till eleven att brukaren "brukar schåpa sig och gnälla över allt", ändå bemöter hon inte honom på ett annat sätt för att underlätta lidandet för brukaren.

B) Autonomi

Patienten har inget självbestämmande och har inte fått vara delaktig kring någonting gällande situationen. Sjuksköterskan gör många fel. Hon presenterar varken sig själv eller studenten, frågar inte om det är okej att en student är med och kollar på, frågar inte patienten om det passar just nu att spola katetern eller talar om för honom vad hon ska utföra. Det är också kränkande att dra ned täcket och kalsongerna utan att tala om varför och få ett godkännande. Det är först efter att patienten ifrågasätter vad SSK håller på med som hon berättar vad de ska göra och pga hennes bemötande blir det en diskussion som hade kunnat undvikas om hon gett informationen från början och haft ett bra bemötande.

C) Icke skada

SSK har kränkt integriteten genom att inte fråga om hon får ta bort täcket och dra ned kalsongerna för att kunna spola kad. Hon gör detta dessutom med en främmande människa i rummet som hon inte heller har presenterat eller frågat patienten om det är okej att han är med. SSK har inte alls tagit hänsyn till patienten i sin helhet utan har endast sätt till vad hon ska göra rent praktiskt. Han visar tydliga signaler att han både fysiskt och psykiskt tycker situationen är obehaglig då han ser ledsen och förvirrad ut. Men också att SSK själv berättar att han brukar schåpa sig och gnälla över allt man ska göra med honom men ändå inte agerar annorlunda.

D) Rättvisa

Redan innan de går in till patienten berättar SSK för studenten att han missbrukat alkohol och tagit droger. Något som inte är relevant information utifrån vad de ska utföra. Det är tydligt att SSK är dömande mot patienten pga ordval och kroppsspråk och dessutom ser hon patienten som ett oobjekt. Hon tar inte hänsyn till hans integritet, känslor och värdighet.

2. A) Pliktetik

Utifrån pliktetiken så lyckades SSK med det hon skulle göra då pliktetiken inte tar hänsyn till konsekvenser, även om de i detta fall var negativa för patienten så tar pliktetiken inte hänsyn till konsekvenser utan endast om en handling blir utförd eller inte vilket det i detta fall blev.

B) Konsekvensetik

Lyckades SSK inte med det hon skulle göra eftersom patienten var ledsen och förvirrad. Att SSK utförde det hon skulle göra vilket var att spola katetern spelar ingen roll eftersom brukaren fick en dålig upplevelse under hela processen. Konsekvensen av sjuksköterskans agerande gjorde också att eleven inte fick någon bra utbildning på momentet.

C) Dygdetik

SSK saknar nästan alla värdefulla karaktärsdrag. Hon har inte medlidande utan fördömer patienten innan de går in till honom, hon har dåligt omdöme eftersom hon inte ändrar sitt agerande fast hon är medveten om att brukaren brukar "schåpa sig och gnälla på allt" och är inte en pålitlig kollega eller handledare. Hon har ingen respekt för patientens integritet när hon drar ned täcket och kalsongerna. Det enda ssk möjligtvis hade var plikt känsla, hon gör det hon ska men på fel sätt.

Utifrån elevens perspektiv har inte heller eleven agerat utifrån denna etiska teori. Som sjuksköterska har man en skyldighet att rapportera om en vårdtagare inte blir behandlad bra.

D) Närhetsetik

Behandlar patienten som ett objekt. För ingen dialog kring vad SSK ska göra. Möter inte patienten i dennes sårbarhet och den utsatta situationen som brukaren befinner sig i med en elev som dessutom närvarar. Sjuksköterskan försöker inte heller bygga en bra relation till brukaren.

3. A) Integritet

Rumslig integritet: tar inte hänsyn till patientens fysiska integritet. Har rätt att veta vilka människor som är hemma hos honom.

Fysisk integritet: kränker också brukarens fysiska integritet när hon sliter av täcke/kalsonger.

Informationsintegritet: hon informerar inte heller brukaren vad hon ska göra.

B) Människosyn

Redan innan de gick in till patienten visade hon tydligt för eleven att hon ser ned på honom som människa eftersom hon berättar att han är missbrukare och alkoholist. Något som är helt irrelevant information utifrån vad de ska göra. SSK tar inte hänsyn till brukarens sociala, psykiska och existentiella behov. Möjligtvis de fysiska eftersom hon spolar katetern. SSK behandlar dessutom brukaren som ett objekt.

C) Världighet

Hon behandlar patienten som ett objekt och inte som ett subjekt. Visar att hon tycker att han är värd mindre än andra pga sina tidigare missbruksproblem. Hon ser inte att brukaren har ett värde pga detta. Världigheten är hand i hand som de etiska principerna, där sjuksköterskan inte agerar rätt.

D) Mod

Eleven tänker och förstår att situationen är felaktig och att SSK inte beter sig rätt. Behöver därav agera utefter det och inte låta det förbipassera.

E) Ansvar

Studenten hade kunnat ta eget ansvar och presenterat sig. Man kan inte säga till handledaren i situationen där de står på rummet hos patienten, men behöver prata med henne efter. Eventuellt gå till chefen eller läraren. Sjuksköterskan tar inte heller ansvar att eleven ska få en bra upplevelse av VFU:n eller en bra handledning i moment.

4. Utgår från 1;3 där SSK inte följer koden. Hon säkerställer inte att patienten får begriplig, korrekt och tillräcklig information i rätt tid då hon informerar patienten efter att han ifrågasätter vad SSK gör. Patienten samtycker inte heller till vård eller behandling. Även om patienten ev har kognitiv svikt eller lider av annan funktionsnedsättning har han fortfarande rätt till information och delaktighet i sin egen vård och därav är det ännu mer relevant att informera honom på ett tydligt sätt.

Fall 2

1. A) Att göra gott

Adnan försöker att hjälpa Sten, men Sten motsätter sig den hjälpen då det inte blir som han är van med. Adnan hade kunnat väcka Sten utan att ropa på honom, försiktigt gått in i sovrummet och väckt honom försiktigt och sedan förklarat varför Karl inte kommer men sagt något i stil med "jag hoppas det går bra att jag hjälper dig istället".

B) Autonomi

Adnan har frågat brukaren om han ska ha hjälp med medicin eller frukost först men brukaren motsätter sig allt eftersom hans ordinarie personal inte är där. Adnan respekterar ändå hans beslut att han ska gå därifrån och därav har brukaren självbestämmande.

C) Icke skada

Brukaren har en allvarlig sjukdom, och det är därav viktigt att han tar medicinen i tid. Men när brukaren avsäger sig all hjälp så gör han indirekt skada på sig själv och skapar därav ett psykiskt och fysiskt lidande. Personalen går också därifrån då brukaren betar sig hotfullt och rasistiskt mot personalen och går därav därifrån. Personalen indirekt orsakar psykiskt lidande hos brukaren eftersom hans morgon inte blir rutinmässig även om inte det är personalens fel.

D) Rättvisa

Personalen behandlar patienten rättvist och försöker hjälpa honom trots att han gör motstånd. Han respekterar ändå hans vilja och går därifrån. Däremot behandlar brukaren personalen väldigt orättvist eftersom han är rasistisk.

2. A) Pliktetik

Enligt pliktetiken utför inte personalen sitt arbete då han inte lyckas utföra jobbet han är där för, för att respektera brukarens autonomi, integritet och självbestämmande. Konsekvenserna blir ju dock stora då brukaren inte får sin viktiga medicin och omvårdnaden som han behöver.

B) Konsekvensetik

Enligt konsekvensetiken utförde inte personalen sina arbetsuppgifter då han valde att avbryta situationen och gå därifrån. Både handlingen och konsekvenserna var därav negativa, då personalen inte lyckades utföra arbetsuppgifterna och brukaren dessutom var mycket upprörd.

C) Dygd etik

Personalen visar medlidande, omdöme, pålitlighet, integritet och plikt känsla. Även om han inte lyckas med sin arbetsuppgift.

D) Närhetsetik

Personalen lyckas även på denna punkt, han försökte prata med patienten om varför Karl inte är där och visar även empati för det men att patienten inte lyssnar är inte personalens ansvar.

3. A) Sårbarhet

Det är svårt för personalen att möta patientens sårbarhet när patienten är så upprörd. Personalen förstår patienten men då han är så upprörd blir det svårt att vända situationen och då är det bättre att lämna och skicka annan personal precis som han gör.

B) Integritet

Personalen visar hänsyn till patientens integritet då han går när patienten säger att han vill det.

C) Människosyn

Personalen har en bra människosyn och respekterar patienten.

D) Värdighet

Behandlar patienten bra och är respektfull.

E) Ansvar

Personalen bör ringa anhöriga/kollega och be dem komma och hjälpa patienten så han får hjälp med medicin och frukost.

4. Utgår från 1;2 där personalen följer koden. Han respekterar patienten samtidigt som han skyddar sig själv när han går därifrån.

Fall 3

1. Göra gott = Lisa handlar inte till brukarens fördel eftersom hon inte bara filmar brukaren utan också sprider klippet vidare.
Icke skada = hon orsakar inte fysiskt skada men psykisk skada då handlingen att filma brukaren är kränkande
Autonomi = har inte heller tagit hänsyn till. Brukaren har inte gett samtycke att bli filmad i en sådan utsatt situation och dessutom sprids klippet vidare.
Rättvisa = hon behandlar inte brukaren rättvist och verkar inte förstå att det är en människa som är lika mycket värd som henne själv som sitter där. Hon själv hade nog inte velat bli filmad i en sådan utsatt situation.
2. A) Pliktetik = utifrån pliktetiken var syftet att gå introduktionen vilket hon har gjort gjort så där har hon lyckats. Pliktetiken tar inte hänsyn till konsekvenserna, som i detta fall var att hon filmade en brukare.
B) = Konsekvenserna vart dåliga eftersom hon kränkte brukarens integritet och spred information om henne utan medgivande.
C) Dygd etik = här har hon misslyckats. Hon har varken visat medlidande, omdöme, pålitlighet och plikt känsla

D) Närhetsetik = hon behandlar brukaren som ett objekt och inte ett subjekt så därför har hon misslyckats även här.

3. A) sårbarhet = hon visar inte brukaren empati och stöd för den utsatta situationen brukaren befinner sig i när hon ska duscha
B) Världighet = brukarens integritet och världighet respekteras inte. Hon ser inte brukarens unika värde.
C) Ansvar = Hon följer inte lagar eller författningar. Hon tar inte något ansvar för att brukarens utsatthet.
D) Lidande = hon tar inte ansvar för det psykiska lidandet hon utsätter brukaren för genom denna integritetskränkning
E) Tillit = Hon bygger inte heller en förtroendefull relation mellan brukaren och sig själv som är personal.
4. 1.5 Sjuksköterskor respekterar både kollegors och patienters rätt till privatliv och konfidentialitet. Sjuksköterskor upprätthåller sjuksköterskeyrkets integritet, såväl i personliga möten samt i kommunikation med media, inklusive i sociala medier.

Enligt denna etiska kod har personalen misslyckats. Hon har inte upprätthållit brukarens integritet, och dessutom filmat och spridit detta i sociala medier.

Fall 4

Göra gott: hon handlar till brukarens fördel eftersom personalen ser till att brukaren få duscha.

Icke skada: hon orsakar genom sitt agerande inte psykiskt eller fysiskt lidande

Autonomi: brukaren fick själv bestämma om han ville "gå på spa" och var därav med och fattade ett eget beslut och därför respekterades autonomin.

Rättvisa: hon kanske inte låter alla sina brukare "gå på spa" men det är heller inte alla brukare som behöver den typ av uppmuntring för att duscha och därav blir hennes behandling rättvis.

2.

A) Pliktetik = hennes mål var att brukaren skulle duscha och det målet uppnådde hon

B) Konsekvensetik= konsekvenserna av hennes utförande vart också positiva då brukaren var nöjd och duschade

C) Dygd etik= grundar sig också i ett bra motiv. Personalen har haft medlidande, omdöme, pålitlighet och plikt känsla

Närhetsetik = också bra. Skapade en bra relation med brukaren och ser brukaren som ett subjekt.

3.

A) Mod = hon står patientens behov och fattar beslut som är till hans fördel även om han får en annan behandling än andra brukare.

B) Lidande = hon förstår att brukaren inte vill duscha och gör därav det bästa av situationen och minskar där med lidandet.

C) Värdighet = hon upprätthåller brukarens värdighet eftersom hon själv får vara med och bestämma

D) Empati = personalen sätter sig in i brukarens situation och gör det bästa utav den

E) Välbefinnande = personalen ökar brukarens välbefinnande eftersom hon inte behöver bråka med brukaren för att få in honom i duschen eller tvinga honom, utan han får duscha men på sina egna villkor och ökar där med brukarens välbefinnande.

4.

1.8 Sjuksköterskor visar professionella värderingar som respekt, rättvisa, lyhördhet, omsorg, medkänsla, empati, tillit och integritet. De stödjer och respekterar alla människors värdighet och allmänmänskliga rättigheter, inkluderat patienter, närstående och kollegor.

Personalen visat allt detta, respekt, rättvisa (även om alla inte får samma behandling är vården rättvis) lyhördhet för brukarens behov, medkänsla, empati, tillit och integritet. Hon tar också närstående i beaktning eftersom hon löser problemet och brukaren får duscha. Något närstående skämdes över att han inte gjorde.

Fall 5

Intersektionalitet = korsning/skärning. Olika faktorer, normer och diskrimineringsgrunder spelar roll samtidigt och påverkar och ibland förstärker varandra i mötet med människor. Detta kan påverka och samverka till patientens vårdupplevelse. Exempel på sådana faktorer kan vara etnicitet, sexualitet, kön, funktionsvariationer och ålder.

Man kan koppla intersektionalitet till detta fall då läkaren förutsätter att hon pga att hon är kvinna och är i fertil ålder kanske vill bli gravid.

Som sjuksköterska kan man använda sig av ett intersektionellt perspektiv för att se patienten i sin helhet och därav ge rätt behandling.

